

Бланк Закладу

НАКАЗ

від _____

№ _____

Про запобігання та подолання у (назва закладу) проявів стигматизації та дискримінації по відношенню до людей, які стикаються з туберкульозом та іншими соціально значущими захворюваннями

З метою запобігання та подолання проявів стигматизації та дискримінації людей, які стикаються з туберкульозом та іншими соціально значущими хворобами (далі – ТБ/ІСЗХ, стикаються з туберкульозом хворобами, на виконання вимог закупівлі медичних послуг за програмою державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення у (назва закладу).

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити програму запобігання та подолання проявів стигматизації та дискримінації людей, які стикаються з ТБ/ІСЗХ з «__»_____2022 року, згідно Рамкової політики, викладеної у додатку №1.
2. Затвердити:
 - 2.1. Кодекс етичної поведінки медичних працівників, що працюють у _____ (додаток №2).
 - 2.2. Положення про Робочу групу щодо запобігання та протидії стигмі і дискримінації (далі - РГПСіД) до людей, які стикаються з ТБ/ІСЗХ (додаток №3).
 - 2.3. Склад РГПСіД (додаток №4).
 - 2.4. Анкету для оцінки базового рівня знань з питань запобігання та подолання проявів стигми і дискримінації по відношенню до людей, які стикаються з туберкульозом та іншими соціально значущими захворюваннями (додаток №5)
 - 2.5. Анкету для оцінки знань персоналу про туберкульоз (додаток №6)
 - 2.6. Форму для самооцінки закладу на відповідність критеріям закладу, вільного від стигми та дискримінації (додаток №7).
 - 2.7. Форму анонімної анкети з оцінки якості послуг закладу (додаток №8)
 - 2.8. Зразок інформаційного листка про основні принципи політики протидії стигмі і дискримінації (додаток №9)
 - 2.9. Тренінгові матеріали «Формування толерантного ставлення у медичних працівників до людей, які хворіють на ТБ, та представників груп найвищого ризику» (додаток №10).
3. Включити до переліку матеріалів, обов'язкових для ознайомлення персоналу, в тому числі під час первинного інструктажу при прийомі на

роботу до _____, Кодекс етичної поведінки медичних працівників та Тренінгові матеріали «Формування толерантного ставлення у медичних працівників до людей, які хворіють на ТБ, та представників груп найвищого ризику».

4. Доручити:

4.1. Керівникам структурних підрозділів:

4.1.1. Здійснити первинний перегляд відповідності діючих нормативних актів закладу (наказів, стандартних операційних процедур, тощо) та усталеної практики їх виконання щодо їх відповідності вимогам програми запобігання та подолання проявів стигматизації та дискримінації людей, які стикаються з ТБ/ІСЗХ, відповідно до Форми для самооцінки закладу на відповідність критеріям закладу, вільного від стигми (додаток №7)

термін виконання – «___» _____ 202_ р.;

4.1.2. Забезпечити здійснення контрольних переглядів відповідності операційних процедур та умов їх виконання вимогам політики щодо запобігання та подолання проявів стигматизації та дискримінації людей, які стикаються з ТБ/ІСЗХ, відповідно до Форми для самооцінки закладу на відповідність критеріям закладу, вільного від стигми (додаток №7) згідно щорічного плану, що затверджується РГПСіД;

4.1.3. Розміщення та оновлення інформаційного листка про основні принципи політики протидії стигмі і дискримінації (додаток №9) у зонах обслуговування пацієнтів, біля реєстратури, в кожному відділенні та на інформаційних стендах

термін виконання – «___» _____ 202_ р.;

4.2. Керівнику РГПСіД забезпечити:

4.2.1. Складання та щорічне оновлювання плана-графіка роботи РГПСіД
термін виконання – «___» _____ 202_ р.;

4.2.2. Складання графіка навчання персоналу щодо формування толерантного ставлення до людей, які стикаються з ТБ/ІСЗХ
термін виконання – «___» _____ 202_ р.;

4.2.3. Виконання плану-графіку роботи РГПСіД до пацієнтів з ТБ та представників груп найвищого ризику з боку медичного персоналу.

4.2.4. Налагодження комунікацій з представниками протитуберкульозної служби та неурядових організацій з метою залучення додаткових ресурсів та отримання технічної допомоги у проведенні тренінгів та інших заходів, спрямованих на удосконалення навичок та підвищення рівня знань персоналу щодо запобігання та протидії стигмі і дискримінації по відношенню до людей, які стикаються з ТБ/ІСЗХ;

4.2.5. Організацію проведення контролю базових знань персоналу щодо туберкульозу згідно з Формуляром для оцінки знань персоналу;

- 4.2.6. Організацію навчання персоналу з питань запобігання та подолання проявів стигматизації та дискримінації людей, які стикаються з ТБ/ІСЗХ, в тому числі на засадах самостійного ознайомлення з тренінговими матеріалами «Формування толерантного ставлення у медичних працівників до людей, які хворіють на ТБ, та представників груп найвищого ризику» згідно графіка, зазначеного у п. 4.2.2.
- 4.3. Начальнику відділу кадрів забезпечити:
- 4.3.1. Долучення Кодексу етичної поведінки медичних працівників до переліку локальних актів підприємства, обов'язкових для ознайомлення осіб, з якими укладаються трудові договори при прийомі на роботу
термін виконання – «___»_____202__ р.;
- 4.3.2. Приведення у відповідність з цим наказом форми розписки працівника про ознайомлення з локальними актами підприємства та зобов'язання про їх дотримання
термін виконання – «___»_____202__ р.;
- 4.3.3. Ознайомлення персоналу з основними принципами та положеннями Кодексу етичної поведінки медичних працівників
термін виконання – «___»_____202__ р.;
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

**РАМКОВА ПОЛІТИКА
запобігання та подолання проявів
стигматизації та дискримінації людей,
які стикаються з туберкульозом,
іншими соціально значущими
хворобами та
груп найвищого ризику**



Стигма та дискримінація визнані найбільш суттєвими бар'єрами, пов'язаними з порушенням прав людини, що перешкоджають подоланню туберкульозу, обмежують доступ до медичної допомоги та негативно впливають на якість життя людей, які стикаються з туберкульозом, іншими соціально значущими хворобами (ТБ/ІСЗХ) та груп найвищого ризику (ГНР). Подолання стигми та дискримінації, визначено одним з ключових завдань Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року.

Прояви стигми в медичних закладах є особливо відчутними, адже вони негативно впливають на людей в той час, коли вони є найбільш уразливими. Відтак, здійснення послідовної та цілісної програми заходів на протидію стигмі та дискримінації є нагальним завданням для усіх закладів охорони здоров'я, що надають допомогу людям, які стикаються з ТБ/ІСЗХ та ГНР.

Спираючись на чинне законодавство України та на державні гарантії в сфері охорони здоров'я, ця політика визначає наступні рамкові принципи та ключові підходи до впровадження цілісної стратегії на протидію стигмі та дискримінації у медичних закладах:

tbpeopleua@gmail.com
<https://tbpeopleukraine.com/>
+38 (067) 100-93-07



Засади

ця політика ґрунтується на традиційних для українського суспільства цінностях рівності, взаємної поваги та підтримки, закріплених у Конституції України та чинному законодавстві, зокрема, Законах України «Основи законодавства про охорону здоров'я в Україні», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про протидію захворюванню на туберкульоз», тощо.

Мета

підвищення доступності та якості допомоги, яка надається пацієнтам та відвідувачам закладу, шляхом усунення перешкод, пов'язаних з упередженістю, побоюваннями, проявами недружнього до пацієнта ставлення як з боку медичних працівників, так і з боку громадськості.

Цілі

- створення сталого середовища, вільного від проявів та ризиків виникнення стигми та дискримінації по відношенню до людей, які стикаються з ТБ/ІСЗХ та ГНР;
 - запровадження механізмів моніторингу відповідності усіх операційних процедур, що застосовуються у закладі, принципам та вимогам політики запобігання та подолання проявів стигматизації та дискримінації;
 - формування культури взаємодії між персоналом, пацієнтами та відвідувачами закладу на засадах довіри, впевненості, взаємоповаги та співробітництва.
- навчання персоналу принципам та навичкам деонтології на засадах Етичного кодексу лікаря України;
 - аудит відповідності закладу принципам політики та вимогам чинного законодавства у сфері охорони здоров'я та запобігання дискримінації;
 - здійснення цільових заходів з попередження та усунення проявів стигми та дискримінації;
 - інформування пацієнтів та відвідувачів закладу про створення та дотримання безпечного середовища, вільного від стигматизації та дискримінації;
 - підтримання зворотного зв'язку між адміністрацією і персоналом, пацієнтами та відвідувачами закладу, щодо доцільності та ефективності заходів на попередження та протидію стигмі та дискримінації.

Ключові напрямки втілення програми:

Часові рамки

програма є безстроковою, що передбачає приділення постійної уваги питанням попередження та усунення проявів стигматизації та дискримінації. Часові рамки реалізації компонентів програми визначаються змістом та обсягом конкретних заходів, що включатимуться до планів дій на відповідний період.

Принципи та критерії реалізації:

Рівний доступ до медичної допомоги та соціально-психологічної підтримки

- забезпечено рівний та своєчасний доступ пацієнтів з ТБ/ІСЗХ та ГНР до медичних послуг, що надаються в закладі, в тому числі, до гарантованого рівня медичної допомоги в обсязі та у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
- медичні послуги, лікування для пацієнтів з ТБ/ІСЗХ та ГНР здійснюються на однаково високому професійному рівні якості як їх отримують інші пацієнти/ки;
- відсутність необґрунтованого перенаправлення пацієнта/ки з ТБ/ІСЗХ та ГНР до інших медичних закладів;

Вільне від упередження та приниження гідності ставлення до пацієнта

- усі послуги надаються з повагою до гідності пацієнта з ТБ/ІСЗХ та ГНР, його духовних і моральних цінностей;
- у спілкуванні використовується толерантна лексика;
- персонал закладу повідомлений про гарантії дотримання прав і свобод пацієнтів з ТБ/ІСЗХ та ГНР;

Забезпечення усвідомленої участі пацієнта у прийнятті рішень щодо медичних втручань

- усвідомлена згода: усна або письмова, – на всі форми діагностики, лікування і медичних досліджень, пов'язаних з захворюванням, з інформацією, наданою відповідно до віку і статі, враховує культурні особливості і поширюється нетехнічним, зрозумілим способом, мовою, зрозумілою людині, яка одержує інформацію;
- пацієнтів долучають до процесу прийняття рішень стосовно методів їх лікування;
- забезпечено можливість надання пацієнтами зворотного зв'язку щодо якості отриманих медичних послуг та рівня медичного обслуговування;

Дотримання лікарської таємниці та захист персоналізованих даних

- інформація щодо діагнозу пацієнта, отримана в ході обстеження та лікування, а також сам факт звернення за медичною допомогою, не розголошується без дозволу пацієнта чи його законного представника;
- забезпечено належне зберігання конфіденційної інформації про пацієнтів з ТБ/ІСЗХ та ГНР та захист інформації від розголошення та розкриття третім особам;

Принципи та критерії реалізації:

Дотримання лікарської таємниці та захист персоніфікованих даних

- забезпечений захист персональних даних пацієнтів відповідно до вимог чинного законодавства України ;
- передача відомостей іншим медичним працівникам та закладам охорони здоров'я допускається виключно за наявності усвідомленої інформованої згоди пацієнта з ТБ на передачу таких відомостей, наданої в письмовому вигляді, лише для цілей, пов'язаних з лікуванням хвороби;

Підтримання безпекової культури закладу та відчуття захищеності персоналу, пацієнтів та відвідувачів

- забезпечено медичне обслуговування пацієнтам з ТБ/ІСЗХ та ГНР на однаково високому професійному рівні якості, як їх отримують інші пацієнти/ки , з дотриманням стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення, які є обов'язковими для всіх закладів охорони здоров'я;
- операційні процедури та умови їх виконання відповідають принципам цієї політики; ї проводиться оцінка рівня знань персоналу, щодо туберкульозу та з питань запобігання та подолання проявів стигми і дискримінації по відношенню до людей, які стикаються з ТБ/ІСЗХ та ГНР;
- персонал закладу пройшов навчання з метою формування толерантного ставлення до людей, які стикаються з ТБ/ІСЗХ;
- персонал ознайомлений з Кодексом етичної поведінки;

Підзвітність за досягнення цілей політики та відповідальність за дотримання вимог чинного з-ва у сфері охорони здоров'я та запобігання дискримінації

- функціонує робоча група щодо запобігання та протидії стигмі і дискримінації;
- налагоджено комунікацію з представниками протитуберкульозної служби та неурядовими організаціями;
- забезпечено можливість анонімної оцінки якості послуг закладу пацієнтами та реагування на неї.

Кодекс етичної поведінки медичних працівників

1. Загальні положення

1.1. Кодекс етичної поведінки працівника є система моральних і професійних цінностей та правил поведінки працівників закладу (далі — Кодекс), призначений для уточнення норм службової поведінки та доброчесності, яких повинні дотримуватися всі працівники закладу.

1.2. Працівники закладу при виконанні своїх службових обов'язків керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, даним Кодексом та загальними морально-етичними нормами поведінки.

1.3. Виконання норм і правил даного Кодексу є обов'язковим для всіх працівників закладу.

2. Мета Кодексу етичної поведінки

2.1. Метою Кодексу етичної поведінки є встановлення етичних норм і правил поведінки медичних працівників, що сприятиме розвитку у закладі середовища, вільного від стигми, та збільшить авторитет і довіру пацієнтів до медичного закладу.

2.2. Кодекс етики покликаний підвищити якість медичних послуг, які надаються закладом.

3. Основні принципи надання медичних послуг у закладі:

Всі послуги які надаються пацієнтам у медичному закладі є людино-орієнтованими та базуються на:

3.1. Здоров'я пацієнта – найвища цінність, на збереження якої спрямована професійна діяльність медичного персоналу.

3.2. Медична допомога хворим у закладі надається незалежно від віку, статі, раси, національності, віросповідання, соціального стану, політичних поглядів, місця проживання, громадянства.

3.3. До всіх пацієнтів у закладі ставляться однаково шанобливо, з дотримання професійної медичної етики та повагою до людської честі і гідності.

3.4. Вся інформація про пацієнта є конфіденційною та не розголошується без його дозволу.

3.5. Пацієнтам надається повна необхідна інформація про захворювання, лікування та\або догляд.

3.6. Пацієнтам надаються найпрофесійніші медичні послуги.

3.7. Пацієнтам забезпечується найкращий можливий у закладі догляд.

4. Зобов'язання медичного працівника (лікаря) щодо пацієнта

4.1. Вищий обов'язок медичного працівника (лікаря) – збереження здоров'я пацієнта
Зобов'язання:

4.1.1. З моменту своєї згоди на звернення хворого взяти на себе особисту моральну відповідальність щодо забезпечення останнього необхідною медичною допомогою.

4.1.2. Стежити за виконанням пацієнтом призначених медичних приписів.

4.1.3. Сприяти реалізації права пацієнта на одержання ним адекватної медичної допомоги.

4.1.4. Використовувати всі необхідні для досягнення блага засоби, сучасні методи діагностики і терапії, у разі потреби – звертатися до інших спеціалістів.

4.1.5. Дотримуватися взятих на себе моральних зобов'язань стосовно пацієнта, навіть у тому випадку, якщо, у силу певних причин, не має змоги надати адекватну медичну допомогу.

4.1.6. Завжди прагнути полегшити страждання свого пацієнта, морально його підтримати.

4.1.7. Не піддівати пацієнта невинуватому ризику.

4.1.8. Не пропонувати хворому лікувальних засобів чи процедур, що не набули широкого розповсюдження або підтвердження своєї лікувальної ефективності в медичній практиці.

4.1.9. Лікар (медичний працівник) повинен поважати психофізичну і духовну цілісність, моральні ідеали, гідність пацієнта і сприяти їхньому утвердженню при наданні медичних послуг.

4.1.10. Поважати автономію пацієнта навіть у випадку несхвалення ним рішення пацієнта щодо відмови від запропонованих окремих процедур чи лікування в цілому.

4.1.11. Негуманне ставлення до пацієнта, приниження його людської гідності, використання в особистих цілях пацієнта неприпустиме для медичного працівника.

4.2. Конфіденційність, збереження лікарської таємниці та встановлення відносин взаємного співробітництва на благо пацієнта

4.2.1. Медичний працівник (лікар) повинен бути чесним зі своїм пацієнтом, вірним слову, даному пацієнтові.

4.2.2. Не обіцяти нездійсненне.

4.2.3. Не розголошувати без дозволу пацієнта чи його законного представника відомості, отримані в ході обстеження та лікування, а також сам факт звернення за медичною допомогою.

4.2.4. Уся інформація, надана пацієнтом в особистій бесіді, а також дані його обстеження заносяться до спеціальної медичної карти і є конфіденційною.

4.2.5. Вживати всіх необхідних заходів щодо збереження і нерозголошення медичної таємниці, а також конфіденційності інформації про пацієнта на електронних носіях.

4.2.6. При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, у публікаціях повинна бути забезпечена анонімність пацієнта.

4.2.7. Встановлення довірчих взаємовідносин і співробітництво медичного працівника і пацієнта визначають успіх лікування і є одним із головних його обов'язків.

4.2.8. Сприяти усвідомленню та реалізації відповідального ставлення пацієнта до процесу обстеження та лікування.

4.2.9. Авторитарне ставлення лікаря (медичного працівника) до пацієнта без урахування ставлення останнього до процесу лікування неприпустимо, крім тих ситуацій, що вимагають невідкладного медичного втручання.

4.3. Надання інформації, необхідної для якісної медичної допомоги, та одержання добровільної згоди пацієнта

4.3.1. Медичний працівник (лікар) повинен інформувати пацієнта щодо необхідності, ступеня ризику, найближчих і можливих віддалених наслідків для його здоров'я, передбачуваних медичним втручанням, про альтернативні методи лікування, їхню порівняльну ефективність, про права пацієнта та можливості їх захисту.

4.3.2. Інформація, що надається, має бути доступною, повинна викладатися зрозумілою для пацієнта мовою, з урахуванням стану, особливостей особистості й культурного рівня пацієнта.

4.3.3. Сприяти здійсненню права пацієнта ознайомитися з історією своєї хвороби, офіційними документами, будь-якою інформацією, отриманою при його обстеженні та лікуванні.

4.3.4. Сприяти реалізації прав пацієнта скористуватися запропонованими медичними послугами чи відмовитися від них.

4.3.5. Уникати невиправданої наполегливості та нав'язування пацієнтові своєї особистої думки, а також будь-яких релігійних чи атеїстичних поглядів щодо згоди пацієнта на медичне втручання.

4.4. Право пацієнта вільно обирати лікаря у медичному закладі

4.4.1. Сприяти реалізації права пацієнта на вільний вибір лікаря та медичної установи.

4.4.2. Не чинити перешкоди пацієнтові у реалізації права довіри свого подальшого лікування іншому лікареві.

5. Відповідальність за порушення Кодексу етики.

5.1. Поведінка працівника, що перешкоджає ефективній діяльності закладу, підриває авторитет та репутацію закладу та є порушенням Кодексу, може передбачати організаційні, адміністративні або юридичні наслідки, згідно вимог чинного законодавства.

5.2. Розглядом фактів порушення вимог Кодексу етики займається керівництво закладу або призначені ним особи.

5.3. Розгляд питань, пов'язаних з порушенням Кодексу етики, може розглядатися за таких підстав: письмове звернення пацієнта або його родичів, письмове звернення працівника медичного закладу тощо.

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань запобігання та подолання у _____ (назва закладу)
проявів стигматизації та дискримінації по відношенню до людей, які стикаються з
туберкульозом та іншими соціально значущими захворюваннями

1. Робоча група з питань запобігання та подолання у _____ (назва закладу) та його структурних підрозділах (далі - Заклад) проявів стигматизації та дискримінації по відношенню до людей, які стикаються з туберкульозом та іншими соціально значущими захворюваннями (далі – РГПСіД) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним при адміністрації _____ з метою вироблення та координації заходів у визначеній сфері компетенції.
2. Робоча група у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Положенням.
3. Основними завданнями робочої групи є:
 - здійснення моніторингу відповідності Закладу та послуг, що надаються у ньому вимогам законодавства щодо запобігання та подолання проявів стигматизації та дискримінації по відношенню до людей, які стикаються з туберкульозом та іншими соціально значущими захворюваннями;
 - вироблення рекомендацій щодо підвищення кваліфікації співробітників Закладу, удосконалення операційних процедур та засобів їх виконання з метою приведення їх у відповідність з вимогами законодавства щодо запобігання та подолання проявів стигматизації та дискримінації по відношенню до людей, які стикаються з туберкульозом та іншими соціально значущими захворюваннями;
 - складання планів та координація виконання заходів щодо запобігання та подолання проявів стигматизації та дискримінації по відношенню до людей, які стикаються з туберкульозом та іншими соціально значущими захворюваннями.
4. Робоча група відповідно до покладених завдань має право:
 - одержувати в установленому порядку, в тому числі шляхом опитування, необхідні інформацію, документи та інші матеріали від адміністрації Закладу, керівників структурних підрозділів, окремих співробітників та пацієнтів;
 - залучати до участі у своїй роботі представників адміністрації Закладу, керівників структурних підрозділів, окремих співробітників та пацієнтів, а також представників громадських об'єднань та незалежних експертів (за згодою);
 - виступати з рекомендаціями щодо заходів із запобігання та подолання проявів стигматизації та дискримінації по відношенню до людей, які стикаються з туберкульозом та іншими соціально значущими захворюваннями.
5. Персональний склад робочої групи затверджується наказом _____. За поданням голови РГПСіД до персонального складу можуть вноситися зміни.
6. Голова РГПСіД відповідно до наданих повноважень визначає та затверджує порядок денний, підписує протоколи засідань робочої групи.
7. Формою роботи РГПСіД є засідання, що проводяться за рішенням голови.
8. На засіданнях РГПСіД розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
9. Засідання РГПСіД оформлюється протоколом. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні.
10. Засідання робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина членів її персонального складу.
11. Члени робочої групи беруть участь у засіданні особисто.

12. Делегування членами робочої групи своїх повноважень іншим особам забороняється.
13. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації) робочої групи, має право викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації робочої групи подаються на розгляд керівництву _____ з метою прийняття рішення щодо їх реалізації, відповідно до своїх повноважень.

Склад групи щодо протидії стигмі і дискримінації до пацієнтів з ТБ та іншими соціально значущими захворюваннями з боку медичного персоналу

1. ППП_____, директор з медичної частини, керівник групи
2. ППП_____, головна медична сестра
3. ППП_____, завідувач структурного підрозділу
4. ППП_____, завідувач структурного підрозділу
5. старша медична сестра структурного підрозділу

АНКЕТА ОЦІНКИ БАЗОВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ

з питань запобігання та подолання проявів стигми і дискримінації по відношенню до людей, які стикаються з туберкульозом та іншими соціально значущими захворюваннями

1. Стигма

- ☐ це нерівне ставлення до людини або групи людей, обмеження у правах та свободах через певні ознаки чи особливості в умовах, рівних для всіх;
- ☐ певна риса або ознака, яка сильно дискредитує людину для оточуючих в порівнянні з іншими.

2. Причинами виникнення стигми є: (позначити всі вірні варіанти)

- ☐ Брак інформації
- ☐ Сором
- ☐ Страх
- ☐ Упередження

3. Стигма

- ☐ Розділяє людей
- ☐ Об'єднує людей

4. Стигма – це ознака, яка:

- ☐ Дискредитує людину в очах оточення
- ☐ Робить людину більш привабливою для оточення

5. Стигма:

- ☐ Допомагає людині краще адаптуватися в суспільстві
- ☐ Негативно впливає на життя людини

6. Звільнення людини з роботи внаслідок захворювання на ТБ це:

- ☐ Стигматизація
- ☐ Дискримінація

7. Негативне ставлення до людей, які відрізняються від інших це:

- ☐ Стигматизація
- ☐ Дискримінація

8. Стигма – це ознака, яка:

- ☐ Дискредитує людину в очах оточення
- ☐ Робить людину більш привабливою для оточення
- ☐ Не впливає на доступність медичних послуг

9. У людини може бути:

- ☐ декілька стигм
- ☐ лише одна стигма

10. Звільнення людини з роботи внаслідок захворювання на ТБ це:

- ☐ Стигматизація
- ☐ Дискримінація

11. Дискримінація:

- ☐ порушення прав людини
- ☐ відсутність поваги

12. Оберіть (позначте) вірне твердження:

Розкриття статусу членам родини

Відмова у наданні медичних послуг

Обговорення статусу пацієнта з колегами, що не беруть участь у його лікуванні

Розголошення статусу іншим пацієнтам лікарні

Упереджене ставлення до людини через хворобу

Стигма

Стигма

Стигма

Стигма

Стигма

Дискримінація

Дискримінація

Дискримінація

Дискримінація

Дискримінація

Анкета для оцінки обізнаності персоналу

Блок А (загальні питання щодо інформованості про туберкульоз)

2. Якщо в організм людини потрапила туберкульозна паличка, чи обов'язково людина захворіє на ТБ?
 - Так
 - Ні
3. Ознаки ТБ :
 - Кашель або покашлювання більше 2-х тижнів.
 - Підвищення температури тіла (має значення навіть незначне підвищення до 37–37,2).
 - Біль в області грудної клітки при диханні.
 - Схуднення з невизначених причин.
 - Зниження апетиту
 - Запаморочення
 - Підвищене спітніння, особливо вночі.
4. Який захід є основним щодо обмеження розповсюдження ТБ інфекції?:
 - Інфекційний контроль.
 - Своєчасне виявлення та успішне лікування ТБ.
 - Вакцинація БЦЖ.
5. Головним фактором передачі туберкульозної інфекції є:
 - Тісний контакт з хворим на ТБ.
 - Повітря закритого приміщення з інфекційним аерозолем.
 - Кількість осіб у приміщенні.
6. Особа із симптомами, схожими на ТБ спочатку має звернутися до:
 - Лікаря-фтизіатра.
 - Сімейного лікаря.
 - Лікаря-рентгенолога.
7. Чи вистачає флюорографічного обстеження органів грудної клітини для виявлення захворювання на ТБ?
 - Так
 - Ні
8. Чи може глибокий стрес бути поштовхом до початку захворювання на ТБ:
 - Так
 - Ні
9. Найшвидшим та найбільш достовірним методом діагностики ТБ є (надайте одну правильну відповідь):
 - Флюорографічне обстеження органів грудної клітини.
 - Мікроскопічне дослідження мокротиння на МБТ.
 - Скринінгове анкетування.
 - Дослідження мокротиння на GeneXpert.

Блок В (особиста інформація, ставлення та спостереження)

10. Скільки років Ви працюєте в галузі охорони здоров'я?
11. Чи працювали Ви коли-небудь у лікарні/відділенні, що спеціалізується на лікуванні ТБ?
- Так ☐ Ні ☐
12. Приблизно скільком пацієнтам хворим на туберкульоз за останній рік Ви надали медичні послуги
13. Чи викликає у Вас занепокоєння щодо можливого інфікування ТБ через контактування з одягом хворої на туберкульоз людини, вимірюванням температури, забором крові, обробкою ран, наданні іншої медичної допомоги?
- ☐ Не викликає взагалі
 - ☐ Відчуваю деяке занепокоєння
 - ☐ Переживаю
 - ☐ Дуже переживаю
 - ☐ Не контактую
14. Чи використовуєте Ви при наданні медичних послуг пацієнтам з ТБ засоби додаткового захисту? (якщо відповідь так, позначте, які саме)
- Так ☐ Ні ☐
-
15. Чи помічали Ви протягом останнього року у вашому закладі наступне:
- ☐ Небажання надавати медичні послуги пацієнтами з підозрою або хворим на ТБ ?
 - ☐ Безпідставне перенаправлення пацієнта з ТБ до іншого медичного закладу?
 - ☐ Надання пацієнтам з ТБ послуг нижчої якості в порівнянні з іншими пацієнтами?
 - ☐ Упереджене ставлення до людей, які хворіють на туберкульоз?
 - ☐ Використання образливої лексики у спілкуванні з пацієнтами ?
 - ☐ Порушення конфіденційності щодо стану здоров'я пацієнта (розголошення діагнозу)?
- Так ☐ Ні ☐ (якщо, відповідь так, позначте із списку переліку, що саме)
16. Чи Ви погоджуєтесь із наступними твердженнями?
- ☐ Туберкульоз - це хвороба людей з неправильним способом життя, безпритульних і знедолених.
 - ☐ Туберкульоз краще лікувати в стаціонарі.
 - ☐ Якщо в організм потрапив збудник туберкульозу, то людина захворіє.
- Так ☐ Ні ☐ (якщо, відповідь так, позначте із списку переліку, що саме)
17. Чи погоджуєтесь Ви з тим, що родина пацієнта в якого виявили ТБ, має бути повідомлена про його діагноз?
- Так ☐ Ні ☐

18. Чи є проведення діагностики на туберкульоз та інші захворювання добровільними та супроводжуються інформованою згодою пацієнта?

Так ☐ Ні ☐

19. Чи помічали Ви зміну ставлення до себе \обмеження спілкування або уникання з боку ваших колег, друзів чи родичів, яке ви пов'язуєте з роботою, а саме, контактуванням та наданням послуг пацієнтам з ТБ?

Так ☐ Ні ☐

20. Ви вважаєте, що маєте достатньо інформації стосовно захворювання, симптомів, шляхів його передачі, діагностики, захисту та профілактики?

Так ☐ Ні ☐

21. Ви вважаєте, що маєте достатньо інформації, щодо консультування людей, які хворіють на ТБ

22. Так Ні

ФОРМУЛЯР
для оцінки закладу (підрозділу) щодо запобігання та подолання проявів стигми та дискримінації по відношенню до людей, які стикаються з туберкульозом та іншими соціально значущими захворюваннями
« ____ » _____ року

Цей формуляр допоможе оцінити, наскільки ваша установа (підрозділ) підтримує та надає медичні послуги людям з туберкульозом без стигми

	Відповідь				
	Т а к / з а в ж д и	П е р е в а ж н о	І н к о л и	Н і / н і к о л и	Н е з н а ю
I. Рівний доступ до якісних послуг					
Заклад (підрозділ) забезпечує рівний доступ до медичних послуг та інформації незалежно від : • ВІЛ –статусу • наявного діагнозу «Туберкульоз» • психічних захворювань • сексуальної орієнтації • гендерної ідентичності • ризикованої поведінки (вживання ін'єкційних наркотиків, одностатеві стосунки)					
Люди з туберкульозом інтегруються з іншими пацієнтами, окрім ситуацій, коли є медична підстава для ізоляції					
Усі тести на туберкульоз та інші захворювання є добровільними та проводяться за усвідомленою згодою					
II. Конфіденційність					
Інформація про ТБ-статус повідомляється тільки пацієнту та медичним працівникам, які дотичні до лікування, а в інших випадках є суворо конфіденційною					
Діагноз не розкривається членам сім'ї пацієнтів, за винятком чіткої, усвідомленої згоди пацієнта					
Приватні питання охорони здоров'я, такі як статус туберкульозу, обговорюються з пацієнтом в приміщенні, де інші не можуть почути розмову					
Записи щодо стану здоров'я пацієнтів зберігаються з дотриманням необхідних умов збереження конфіденційності					
Технічний персонал медичного закладу (підрозділу) не має доступу до конфіденційної інформації про пацієнта					

Приміщення, обладнання, інформаційні повідомлення, палати, персонал та документація не маркуються таким чином, щоб розкрити ТБ – статус та інформацію щодо інших хвороб персоналу або іншим пацієнтам					
III. Безпека					
Стандартні запобіжні заходи застосовуються в однаковій мірі по відношенню до усіх пацієнтів					
Рациональне поводження з відходами виконується усім персоналом					
Увесь персонал проінформований та забезпечений доступом до безкоштовної вакцинації проти гепатиту та, за необхідності, профілактики після контакту з іншими інфекціями					
Необхідні матеріали для стандартних запобіжних заходів, інфекційний контроль доступні рівною мірою для всього персоналу закладу (підрозділу)					
Навчальні матеріали про стандартні запобіжні заходи розміщені у всіх палатах та зонах для персоналу					
IV. Навчання					
Весь персонал проходить навчання щодо стигми та прав пацієнтів з ТБ та інших ключових груп населення					
Усі працівники закладу проходять навчання щодо принципів та процедури добровільного тестування та інформованої згоди					
Усі працівники проходять навчання щодо принципів конфіденційності та права пацієнтів на конфіденційність					
Весь персонал ознайомлений щодо СОПів, основ передачі та профілактики туберкульозу, гепатиту та інших інфекційних захворювань					
Співробітники проходять постійне навчання (БІР) та практикують навички у вищевказаних областях					
V. Управління якістю					
Заклад (підрозділ) вживає заходи щодо усунення порушень, політики та процедур					
Заклад (підрозділ) активно запобігає порушенням політики та процедур					
Наглядові органи заохочують середовище без стигми та допомагають працівникам у забезпеченні нестигматизуючих послуг					
Доступним є спосіб реєстрації скарг пацієнтів					
У зонах очікування розміщені стенди з інформацією про ТБ					

Анонімна анкета з оцінки якості послуг закладу _____ назва _____

1. Оцініть, будь ласка, час очікування надання медичних послуг.
(1 – дуже довго, 5 - швидко)

1 2 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ ☐ ☐

2. Чи підписували Ви інформовану згоду на лікування?
Так Ні ☐ ☐

3. Як Ви оцінюєте ставлення медичного персоналу?
(1 - неетичне, стигматизаційне ставлення; 5 - доброзичливе, уважне ставлення):

1 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐ ☐ ☐

4. Чи відчували Ви стигматизацію або дискримінацію з боку медичного персоналу?
Так Ні ☐ ☐

5. Чи стикались Ви з порушенням конфіденційності, несанкціонованим поширенням інформації про діагноз?
Так Ні ☐ ☐

6. Чи відмовляли Вам у наданні медичних послуг?
Так Ні ☐ ☐

7. Загалом наскільки Ви задоволені якістю послуг отриманих у закладі?
(1- зовсім незадоволений, 5- повністю задоволений)

1 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐ ☐ ☐

Ви можете залишити Ваші побажання щодо покращення якості надання послуг, відгук про отримані медичні послуги або описати проблему з якою стикнулися. Для отримання зворотного зв'язку залиште Ваші контакти.

Отримати додаткову інформацію про туберкульоз, дізнатися про заклади, які надають протитуберкульозні послуги, подати звернення щодо проблем пов'язаних з доступом до якісних протитуберкульозних послуг з лікування, догляду й підтримки і отримати допомогу від команди реагування Ви можете скориставшись мобільним додатком OneImpact.

Завантажуй додаток тут:



Анкета є добровільною. Відомості, отримані при обробці даних анкети, будуть використані для вдосконалення якості послуг медичного закладу.

Основні принципи політики протидії стигмі і дискримінації

ЗДОРОВ'Я ТА ГІДНІСТЬ – НАЙВИЩІ ЦІННОСТІ!

Заклад використовує пацієнт-орієнтований підхід до лікування ТБ та інших соціально значущих захворювань і гарантує пацієнтам:

- рівний доступ до медичних послуг
- толерантне, уважне ставлення
- право на усвідомлену згоду плану лікування
- конфіденційність
- якість надання допомоги на найвищому рівні
- дотримання безпеки лікувально-діагностичного процесу для пацієнтів та персоналу

Отримати інформацію про хворобу та права людей з туберкульозом, повідомити про бар'єри, пов'язані з доступом до протитуберкульозних послуг з лікування, в тому числі про прояви стигми та дискримінації, отримати допомогу від команди реагування Ви можете скориставшись мобільним застосунком OneImpactUkraine

Завантажуй застосунок тут:



Посилання на тренінгові матеріали:

<https://drive.google.com/file/d/19dKuoAJvbOoRBqTZTCpW5qysAvvxAlIB/view?usp=sharing>

ПОСІБНИК ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ

**Формування
толерантного ставлення
у медичних працівників
до людей, які хворіють на ТБ,
та представників груп
найвищого ризику**

Розробники:

Лариса Валова

психолог, тренер,
консультант МБФ «Альянс
громадського здоров'я»

Ірина Волошина

лікар, д. мед. н., професор
кафедри сімейної медицини
ФПО ЗДМУ



(призначений для внесення змін та доповнень до існуючого порядку розгляду звернень громадян (за потреби)).

Орієнтовний алгоритм вивчення і розслідування інцидентів, пов'язаних з випадками стигматизації чи дискримінації, розгляду скарг і пошуку шляхів їх врегулювання

Адміністрація закладу первинної ланки медичної допомоги визначає процедуру розслідування інцидентів, пов'язаних з випадками стигматизації та дискримінації, яка передбачає:

- розгляд усних звернень;
- розгляд письмових звернень (заяви, скарги, пропозиції);
- реагування на випадки стигматизації та дискримінації людей, які хворіють на ТБ та представників ключових груп щодо ТБ адміністрацією лікувального закладу, застосування санкцій.

Розгляд усних звернень

Ø Усні звернення громадян, у тому числі й людей, які хворіють на ТБ і представників ключових груп щодо ТБ, безпосередньо розглядаються та вирішуються посадовими особами закладу первинної ланки медичної допомоги під час особистого прийому громадян.

Ø Порядок прийому громадян, у тому числі й людей, які хворіють на ТБ і представників ключових груп щодо ТБ, визначається та затверджується головним лікарем/керівником закладу первинної ланки медичної допомоги.

Ø Усні звернення громадян, у тому числі й людей, які хворіють на ТБ і представників ключових груп щодо ТБ, подаються у спосіб підпорядкування, починаючи з посадовця того рівня, в компетенцію якого входить розгляд звернень.

Ø Усі звернення громадян, у тому числі й людей, які хворіють на ТБ і представників ключових груп щодо ТБ, на особистому прийомі реєструються в «Журналі обліку особистого прийому громадян».

Ø Особистий прийом проводиться згідно із затвердженим графіком регулярно в установлені дні та години у зручний для громадян час. Графік прийому доводиться до відома пацієнтів, розміщується на видному та зручному місці (біля кабінету, реєстратури, на інформаційних стендах тощо).

Ø Якщо розв'язати порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, вони розглядаються в тому самому порядку, що й при письмовому зверненні.

Ø Результати розгляду усного звернення повідомляються громадянину письмово або усно за його бажанням, про що робиться позначка в «Журналі обліку особистого прийому громадян».

Розгляд письмових звернень

- ✓ Письмові звернення громадян, в тому числі й людей, які хворіють на ТБ і представників ключових груп щодо ТБ, підлягають обов'язковому первинному розгляду з метою вивчення випадків стигматизації та дискримінації, а також пошуку шляхів їх врегулювання, відновлення порушених прав.
- ✓ Первинний розгляд письмових звернень громадян, у тому числі й людей, які хворіють на ТБ і представників ключових груп щодо ТБ, проводиться тим фахівцем, на ім'я якого була подана скарга.
- ✓ Письмові звернення підлягають централізованій реєстрації в «Журналі реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян».
- ✓ Листування щодо звернень громадян, у тому числі й людей, які хворіють на ТБ і представників ключових груп щодо ТБ, ведеться за номерами, наданими під час реєстрації (вхідний і вихідний номери однакові). Відповіді на звернення громадян, у тому числі й людей, які хворіють на ТБ і представників ключових груп щодо ТБ, надсилаються на службових бланках закладу первинної ланки медичної допомоги.
- ✓ Кожне письмове звернення підлягає розгляду, детальному вивченню ситуації, потребує ухвалення рішення щодо подальшого впровадження. Щодо кожного звернення відповідно до ситуації та не пізніше ніж у п'ятиденний термін ухвалюється одне з таких рішень:
 - взяти до виконання в закладі первинної ланки медичної допомоги;
 - перенаправити за призначенням до іншого відомства, якщо питання, порушені у зверненні, не входять до компетенції закладу первинної ланки медичної допомоги, про що одночасно повідомляється заявнику;
 - переадресувати до громадської організації за умови згоди пацієнта у випадку, коли пацієнт який хворіє на ТБ чи представник ключової групи щодо ТБ, з певних причин будуть неспроможні самостійно захистити свої права та інтереси і зазнають стигматизації та дискримінації з боку персоналу закладу первинної ланки медичної допомоги;
 - залишити без розгляду за наявності таких підстав, як: подання анонімного письмового звернення без зазначення місця проживання, не підписаного автором (авторами), а також такого, з якого неможливо встановити авторство; повторне звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними тощо)[3] .
- ✓ Після закінчення перевірки наданих у зверненні даних і фактичного виконання ухваленого рішення, звернення разом з матеріалами перевірки повертається до загального відділу (канцелярії) закладу первинної ланки медичної допомоги з написом «До справи» та підписом посадової особи, яка ухвалила рішення.
- ✓ Документи й листування щодо звернень громадян, у тому числі й людей, які хворіють на ТБ і представників ключових груп щодо ТБ, з часу надходження їх до загального

відділу (канцелярії) і до передання в архів централізовано зберігаються в загальному відділі.

- ✓ Збереження документів і листування щодо звернень громадян, у тому числі й людей, які хворіють на ТБ і представників ключових груп щодо ТБ, забезпечується посадовими особами, відповідальними за діловодство.
- ✓ Терміни зберігання документів за пропозиціями, заявами і скаргами визначаються керівниками закладу первинної ланки медичної допомоги.

Забезпечення доступності та дієвості процедури подання скарги людям, які хворіють на ТБ та представниками ключових груп щодо ТБ

При розгляді скарги головний лікар, адміністрація закладу первинної ланки медичної допомоги мають такі обов'язки:

- об'єктивно, всебічно та вчасно перевіряти заяви чи скарги;
- на прохання людини, яка хворіє на ТБ, і представника ключових груп щодо ТБ запрошувати його та/або представника його інтересів на засідання відповідної установи, що розглядає його заяву чи скаргу;
- скасовувати або змінювати оскаржені рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам;
- невідкладно вживати заходів щодо припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенню;
- забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання ухвалених у зв'язку із заявою чи скаргою рішень;
- письмово повідомляти людину, яка хворіє на ТБ, та представника ключових груп щодо ТБ про результати перевірки заяви чи скарги і суть ухваленого рішення;
- вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення;
- за визнання заяви чи скарги необґрунтованою, роз'яснити людині, яка хворіє на ТБ та представнику ключових груп щодо ТБ порядок оскарження ухваленого за нею рішення;
- не допускати безпідставного передання розгляду заяв чи скарг іншим установам;
- особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг людей, які хворіють на ТБ, і представників ключових груп щодо ТБ, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи;
- вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано людині, яка хворіє на ТБ і представнику ключових груп щодо ТБ у результаті порушення його прав чи законних інтересів.

Терміни розгляду скарги[4]:

- Адміністрація закладу первинної ланки медичної допомоги зобов'язана розглянути скаргу відповідно до чинного законодавства України не пізніше ніж за 30 днів з моменту подання скарги.

- Скарги, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.
- Якщо за 30 днів вирішити порушені у скарзі питання неможливо, адміністрація закладу первинної ланки медичної допомоги визначає необхідний термін для розгляду скарги, про що зобов'язана повідомити особу, яка подала звернення (людину, яка хворіє на ТБ та представника ключових груп щодо ТБ). При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у скарзі, не може перевищувати 45 днів.

Використання права звернення зі скаргою до адміністрації закладу первинної ланки медичної допомоги не може бути підставою для упередженого ставлення, а також не може спричиняти жодних негативних наслідків стосовно людини, яка хворіє на ТБ та представника ключових груп щодо, яка/ий використовує таке право.

Процедура примирення та посередницькі процедури

Якщо дві сторони конфлікту погодилися врегулювати ситуацію шляхом участі в процедурі примирення та посередницьких процедурах, адміністрація закладу первинної ланки медичної допомоги повинна вжити необхідних заходів та створити відповідні умови.

Процедура примирення передбачає зустріч обох сторін, обговорення питань, пов'язаних із порушенням прав, випадками стигматизації і дискримінації людей, які хворіють на ТБ та/або представників ключових груп щодо ТБ, забезпечення адекватного реагування на ситуацію, задоволення порушених прав та відновлення справедливості.

Всі умови та процедури проведення примирення узгоджуються зі сторонами завчасно.

- Процедура примирення передбачає дотримання принципу конфіденційності, спрямована на:
- досягнення сторонами взаємовигідного рішення;
- усунення спричиненої шкоди;
- зниження рівня конфліктності сторін, якомога повне задоволення потреб сторін конфлікту, запобігання поновленню конфлікту;
- відновлення порушених прав та встановлення справедливості.

**Примірний план-графік
роботи групи щодо запобігання та протидії проявам стигми і
дискримінації по відношенню до людей, які стикаються з туберкульозом
та іншими соціально значущими захворюваннями
на _____ рік**

№	Заходи	Дата проведення	Відповідальний за виконання	Відмітка про виконання
	Розробка та затвердження щорічного плану-графіку роботи групи щодо протидії стигмі і дискримінації до пацієнтів з ТБ та представників груп найвищого ризику з боку медичного персоналу	січень	Директор з медичної частини (керівник РГПСіД)	
	Проведення анкетування для оцінки знань персоналу з питань туберкульозу (Додаток ____).	лютий	Завідувачі структурних підрозділів (члени РГПСіД)	
	Проведення анкетування для оцінки знань персоналу з питань запобігання та протидії проявам стигми і дискримінації по відношенню до людей, які стикаються з ТБ/ІСЗХ (Додаток ____).	лютий	Завідувачі структурних підрозділів (члени РГПСіД)	
	Здійснення анонімного анкетування пацієнтів щодо оцінки якості послуг з надання медичної допомоги (Додаток ____).	другий місяць кожного кварталу	Старші медичні сестри, медичні сестри, що надають ДОТ послуги	
	Доповідь та затвердження звіту про результати оцінки знань персоналу з питань туберкульозу	травень	_____ член РГПСіД	
	Доповідь та затвердження звіту про результати оцінки знань персоналу з питань запобігання та протидії проявам стигми і дискримінації по відношенню до людей, які стикаються з ТБ/ІСЗХ	травень	_____ член РГПСіД	
	Доповідь та затвердження звіту про результати анонімного анкетування пацієнтів щодо якості послуг з надання медичної допомоги	травень /вересень	_____ член РГПСіД	
	Оновлення інформації про основні принципи політики протидії стигмі і дискримінації (додаток) у зонах обслуговування пацієнтів, біля реєстратури, в кожному відділенні та на інформаційних стендах, сайті закладу.	травень /вересень	Завідувачі структурних підрозділів (члени РГПСіД)	
	Здійснення оцінки відповідності закладу та його структурних підрозділів вимогам програми запобігання та протидії проявам стигми і дискримінації по відношенню до людей, які стикаються з ТБ/ІСЗХ (Додаток ____)	листопад	Завідувачі структурних підрозділів (члени РГПСіД)	
	Обговорення на загальній нараді закладу (підрозділу) та затвердження звіту з аналізу ефективності заходів на протидію стигмі та дискримінації.	грудень	Директор з медичної частини (керівник РГПСіД)	
	Розробка та затвердження плану заходів щодо вирішення проблемних питань, які виявлені в ході аналізу якості впровадження політики протидії стигми та дискримінації у закладі в цілому та в структурних підрозділах.	грудень	Директор з медичної частини (керівник РГПСіД)	
	Проведення заходів з підвищення кваліфікації персоналу з питань запобігання та протидії проявам стигми та дискримінації	Згідно графіку (Додаток ____)	Директор з медичної частини (керівник РГПСіД)	

Довідковий матеріал №3

Навчання з питань запобігання та протидії проявам стигми та дискримінації по відношенню до людей, які стикаються з ТБ/ІСЗХ може здійснюватися у формі а) тренінгів із залученням зовнішніх викладачів; б) навчальних заходів, що проводяться силами персоналу закладу; в) самопідготовки. Звітування про проходження тренінгу відбувається шляхом заповнення вихідної анкети з оцінки знань та навичок, а також розписки співробітника про ознайомлення з тренінговими матеріалами та зобов'язанням щодо дотримання вимог з попередження та подолання проявів стигми та дискримінації.

Примірний графік навчання персоналу щодо формування толерантного ставлення до людей, які стикаються з
ТБ/ІСЗХ

Тема заняття	Відділення	Назва структурного підрозділу	Назва структурного підрозділу	Назва структурного підрозділу	Назва структурного підрозділу	Назва структурного підрозділу
Епідемічна ситуація з ТБ в Україні та світі. Базова інформація про туберкульоз. Огляд законодавства України в сфері охорони здоров'я та протидії ТБ. (матеріал для підготовки навчання ст. 20-30)		Дата проведення	Дата проведення	Дата проведення	Дата проведення	Дата проведення
Поняття «стигма», «стигматизація» та «дискримінація» пов'язані з ТБ. Вплив стигматизації на життя людини. Толерантна лексика. (матеріал для підготовки навчання ст. 30-54)		Дата проведення	Дата проведення	Дата проведення	Дата проведення	Дата проведення
Основи консультування людей, які хворіють на ТБ. (матеріал для підготовки навчання ст. 15-20, 55-56)		Дата проведення	Дата проведення	Дата проведення	Дата проведення	Дата проведення